

08 - 01-Revision anatomie (teams) - Pr. Aniba

(0:04 - 8:03)

D'abord, est-ce que vous arrivez à m'entendre ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Est-ce que vous arrivez à m'entendre ou pas ? Très bien, merci Hussam. Donc, je propose que, si vous voulez, on passe chapitre par chapitre. On peut commencer par l'anatomie de la régence LR.

Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? D'accord. Est-ce que vous avez le support du cours à côté de vous ou à proximité ? Comme ça, je peux passer rapidement. Et si vous avez des éclaircissements dans un point donné, on peut plus ou moins l'éclairer.

Ok, donc, merci Ajaar. Donc, je passe rapidement sur l'anatomie de la régence LR. Donc, si vous avez le support, ce sera plus facile de suivre avec le support à côté.

Donc, on vous a mis comme objectif, donc, à la fin du cours, normalement, vous devez être capable de savoir, d'écrire les différentes parois de la régence LR et de connaître la morphologie de l'hypophyse et de connaître les principaux rapports de la régence LR. Est-ce que vous avez pu, à la fin du cours, acquérir ces différentes compétences ? D'accord. Donc, je rappelle, l'hypophyse est le principal constituant de la régence LR.

Et donc, cette hypophyse, elle est située dans ce qu'on appelle la loge hypophysaire. Comment est la loge hypophysaire ? Qui peut me dire la loge hypophysaire, comment elle est ? Ikram Boumlik, tu voulais répondre ? Elle a la forme d'un parallélepède avec six faces. Oui, ça c'est sa forme.

Mais elle est, on dit que c'est une loge. Qui est ostéofibreuse. Très bien, qui est ostéofibreuse, c'est-à-dire qu'elle a des parois osseuses, mais aussi des parois fibreuses.

Donc, qui peut me dire les parois fibreuses que présente cette loge ? La paroi fibreuse se trouve à quel niveau ? Où les parois fibreuses ? La paroi supérieure, qui est représentée par le diaphragme. Très bien, juste la paroi supérieure ? Latérale. Et les parois latérales.

Donc, les parois latérales sont constituées par quoi ? Le sinus caverneux. Très bien, donc chaque paroi est en rapport avec le sinus caverneux et donc la paroi latérale de la loge hypophysaire répond à la paroi interne du sinus caverneux. Ok ? Bonjour.

Donc, j'insiste sur le fait que cette loge hypophysaire est située dans la portion antérieure et médiane de l'étage moyen de la base du crâne. Donc, ça vous pouvez l'avoir comme question d'examen, par exemple, la loge hypophysaire est située dans l'étage antérieur, l'étage moyen ou l'étage postérieur. Donc, retenez très bien que c'est dans l'étage moyenne et c'est dans sa partie antérieure et médiane.

Aussi, la forme de la loge hypophysaire, qui est une forme parallépipède, avec, vous pouvez aussi

l'avoir comme question, la loge hypophysaire présente à décrire 4 faces, 5 faces, 6 faces, 7 faces, d'accord ? Donc, reprenez que c'est combien de faces ? 6. Très bien. Et qui sont ? De latéraux, de l'intérieur, de l'extérieur, supérieur, inférieur. Très bien.

Vous pouvez aussi avoir des questions par rapport aux différentes parois et les rapports de chaque paroi, d'accord ? Par exemple, quels sont les rapports de la paroi inférieure ? Allo, quels sont les rapports inférieurs de la région scélère ou de la loge hypophysaire ? Très bien. Sinus phénuide et la voûte du rhinopharynx. Très bien, Ouissal.

IBA, ce n'est pas juste le sinus, c'est le sinus et la voûte du rhinopharynx, ok ? Voilà, vous pouvez avoir des questions de ce genre-là. Ce sont des questions en choix multiple, donc il faut faire très attention avant de répondre. Vous pouvez répondre.

J'ai ici une question d'Abdelbast. Il dit, est-ce que le sinus caverneux est entouré par la dure-mère ? Oui. Le sinus, par définissant les sinus, sont des dédoublements de la dure-mère.

(8:04 - 19:40)

Vous avez la dure-mère de partout. Le sinus caverneux est entouré par la dure-mère. Que contient le sinus caverneux ? Qui peut me dire quels sont les constituants du sinus caverneux ? C'est l'artère carotide interne avec l'ensemble des nerfs oculomoteur externe, oculomoteur commun, ophthalmique et pathétique.

Et des sinus veineux. C'est la carotide interne, c'est les nerfs oculomoteur, le 3, le 4, le 6, le nerf ophthalmique, le 5, 1 et des sinus veineux. Madame, pouvez-vous nous aider avec plus d'images pour nous permettre de mieux retenir ? Normalement, on vous a mis des images dans le support.

Dans le support, il y a pas mal d'images qui décrivent les différentes parois. Vous jugez que c'est insuffisant parce que là, je n'ai pas accès pour vous donner plus d'images. Si vous voulez, quelqu'un peut venir me voir après au service pour vous fournir un support avec plus d'images si vous voulez.

Vous voulez des images pour ce cours-là, pour l'anatomie de la région cellulaire, c'est ça ? Je vais voir ça avec le professeur Edniba. Soit on vous met ça sur la plateforme, soit je vous le prépare et éventuellement, quelqu'un peut passer et le récupérer par la suite. Ça va ? Mais là sur le champ, je ne l'ai pas.

Mais le cours, il est riche en iconographie. Vous avez pas mal d'images. Avec plaisir Ariane.

Vous avez d'autres questions ou vous voulez qu'on continue comme on a commencé ? On essaie de passer les différents chapitres de cours. L'ostéopouphise n'a qu'un rôle de stockage. Madame, on n'entend rien.

Madame, il n'y a pas de son. Allô ? Allô ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Est-ce que

vous arrivez à m'entendre maintenant ? Oui, on vous entend. D'accord.

Désolée, il y a eu un petit problème technique. Je ne sais pas, est-ce que vous avez entendu Ali ? Tu as entendu ma réponse ? Ali ? De toute façon, je répète. Ta question était, est-ce que l'ostéopouphise n'a qu'un rôle de stockage ? Non.

L'ostéopouphise sécrète l'hormone antidiurétique, l'ADH. Ce n'est pas juste une fonction de stockage, mais il assure une fonction de sécrétion et de stockage. Est-ce que la paroi supérieure de la loge hypophysaire est fragile ? Oui, c'est une membrane durmérienne.

C'est de la durmère. Elle peut être, au cours d'un geste chirurgical, si on ne fait pas attention, elle peut être ouverte et donner ce qu'on appelle une rhinorée. La paroi supérieure de la loge hypophysaire est durmérienne.

C'est ce qu'on appelle le diaphragme scélère. Et oui, elle est fragile. C'est de la durmère.

C'est fragile. Ce diaphragme scélère peut être ouvert soit accidentellement, soit de façon voulue lors d'une intervention chirurgicale. Et à chaque fois qu'il est ouvert, il y a un risque d'avoir une rhinorée.

Madame, est-ce que le sinus veineux contient du son veineux qui est traversé par les différents éléments du sinus caverneux ? J'ai pas bien compris la question, mais voilà. Dans le sinus caverneux, il y a des veines. Il y a un sinus veineux qui contient des veines, un son veineux.

D'accord ? C'est clair, SIA ? Le sinus veineux contient du son veineux. C'est clair, SIA ? Je répète, les rapports latéraux de la loge hypophysaire, on a les sinus caverneux. Dans chaque sinus caverneux, on a la carotide interne, on a les nerfs oculomoteurs, le 3, le 6 et le 4, le nerf ophtalmique, le 5, 1, et on a un sinus veineux des veines qui contient du sinus veineux.

Madame, quelle est la différence entre une hydrocéphalie communicante et une hydrocéphalie non communicante ? Une hydrocéphalie communicante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Toutes les ventricules sont dilatées. Il n'y a pas d'obstacle, c'est-à-dire qu'il y a une communication entre les différentes ventricules et ces ventricules sont dilatées.

Une hydrocéphalie non communicante, c'est-à-dire qu'il y a une obstruction, qu'il n'y a pas de communication entre certains ventricules. Elle est triventriculaire quand l'obstacle siège au niveau de l'acduque du sylvus, en tout cas au-dessous du troisième ventricule. Donc soit l'acduque du sylvus qui est comprimé, soit le quatrième ventricule qui est comprimé.

(19:41 - 23:58)

À ce moment-là, on a une obstruction et donc tout ce qui est en amont va être dilaté, c'est-à-dire les trois ventricules, les deux ventricules latéraux et les troisièmes ventricules. C'est ce qui donne une hydrocéphalie triventriculaire. Maintenant, on peut avoir une hydrocéphalie triventriculaire soit quand on a une hydrocéphalie non communicante, pardon, une

hydrocéphalie communicante, c'est-à-dire une hydrocéphalie malformative avec une malformation par exemple de la charnière ou une malformation médulaire par exemple une spina bifida.

Vous avez une spina bifida et donc on a un obstacle qui est très bas situé et qui engendre une hydrocéphalie tetraventriculaire. Toutes les ventricules sont dilatées, d'accord? Donc là, ça communique entre les différents ventricules. Hydrocéphalie communicante, c'est-à-dire qu'il y a communication, il n'y a pas d'obstacle.

Hydrocéphalie non communicante, c'est-à-dire il y a un obstacle qui obstrue et donc il n'y a pas de passage entre certains ventricules. Et quand on a une hydrocéphalie non communicante ou obstructive, on peut avoir soit une hydrocéphalie bifentriculaire ou triventriculaire en fonction du siège de l'obstacle. C'est clair, Riba? D'autres questions? Maintenant, vous êtes passé au chapitre du système ventriculaire.

Vous voulez qu'on passe au cours des ventricules? Système ventriculaire, comme ça, on fait le tour. Je veux dire que c'est les formations durmériennes qui protègent ce sang. Je n'ai pas compris.

SIA. Attends, je vais voir un peu plus haut. Tu veux dire que c'est les formations durmériennes qui protègent.

SIA, je n'ai pas compris ta question. SIA, tu peux activer le micro et poser ta question. Clairement, comme ça, je peux te répondre.

Oui, le plexus choroïde existe dans le quatrième ventricule. SIA, tu veux reposer ta question? Pour les voies d'abord de l'hypophyse, on a les voies transcraniales ou les voies hautes et les voies basses. Voie haute et voie basse.

La voie haute est dite voie transcraniale. Un petit moment, je réponds à Zaid et après vous pouvez poser votre question si vous voulez. Donc, Zaid, pour les voies d'abord de l'hypophyse, je répète, il y a les voies hautes par en haut et les voies basses.

(23:59 - 28:58)

Dans les voies hautes, ce sont dites des voies transcraniales. Les voies basses, on passe par en bas et on passe par le sinus phénuïdal. Dans les voies basses, il y a la voie microscopique et la voie endoscopique.

C'est-à-dire, soit on va utiliser un microscope, soit on va utiliser un endoscope. La voie microscopique, c'est aussi transphénuïdal. La voie endoscopique, c'est endonasale.

On passe par le nez. D'accord? C'est clair, Zaid? Voie d'abord de l'hypophyse, voie haute, voie basse. Voie haute, voie transcraniale.

Voie basse, c'est transphénuïdal. Donc, soit microscopique, on passe ici sous l'abial ou voie

endoscopique, on passe par le nez. Endonasale.

La voie endoscopique est une voie endonasale transphénuïdal et c'est la voie qui est utilisée actuellement. Depuis le développement de l'endoscopie, la voie qu'on utilise le plus souvent, c'est la voie endoscopique, c'est-à-dire endonasale transphénuïdal. Trans, c'est-à-dire on passe par le sphénuïde.

Ok. Sia, ton micro ne marche pas, mais je n'ai pas compris ta question, Max. Tu peux la reformuler ou l'écrire de façon plus claire.

Wafa, tu voulais poser une question? J'ai vu tout à l'heure que ton micro était activé. Le plexus coroïde existe dans tous les ventricules, y compris le troisième ventricule. Dans le troisième ventricule, il existe au niveau du foramen du trou de monros.

Pas dans tout le ventricule, mais on le voit au niveau du trou de monros. D'autres questions pour le système ventriculaire? Madame, pouvez-vous nous réexpliquer la notion du système porte-hypophysère? D'accord. Pour la vascularisation de l'hypophyse, on a la vascularisation artérielle et la vascularisation veineuse, comme pour tout chaque organe.

Mais l'hypophyse, il est caractérisé par la présence de système porte. Le système porte est un système artériel formé par des capillaires et ces capillaires se font communiquer des hormones, notamment entre l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est clair? Donc c'est un système qui se trouve notamment dans le système infundibulaire, d'accord? Ça passe dans le système infundibulaire.

C'est un système, oui, artériel, mais la principale fonction, c'est la transmission des hormones. SIA, attendez, je relis la question de SIA. Dans le sinus caverneux, il y a du sang veineux.

Est-ce que ce sang est protégé par les parois veineuses ou seulement par les formations diurmiennes? D'accord. La diurmère, il existe uniquement au niveau de la paroi du sinus caverneux. D'accord? Et pour la paroi des veines qui sont à l'intérieur des sinus, donc les veines, ils ont une paroi veineuse.

Mais la diurmère, elle constitue les parois du sinus caverneux. Donc c'est un sinus, voilà, qui est comme ça, et à l'intérieur, donc le pourtour, c'est de la diurmère, mais à l'intérieur, tu as la carotide et dans la carotide, c'est une paroi artérielle. Il y a des veines et c'est une paroi veineuse et il y a les nerfs.

(28:59 - 31:48)

C'est clair? Essayons maintenant. D'accord. Sarah, pouvez-vous nous réexpliquer comment se font les dérivations ventriculaires? Donc pour les dérivations ventriculaires, ça dépend de l'étiologie.

D'accord? Et d'une façon, on a différents types de dérivations. On a ce qu'on appelle les

dérivations externes et les dérivations internes. Dans les dérivations externes, donc c'est un système avec quoi on va drainer les ventricules avec quelque chose qui se trouve à l'extérieur ou une valve de dérivation qui se trouve à l'extérieur.

En général, dans les drainages ventriculaires externes, on va ponctionner la corne frontale des ventricules latéraux. D'accord? Ça, c'est le drainage ventriculaire externe. Donc, on ponctionne le ventricule.

En général, c'est la corne frontale et donc ce cathéter intraventriculaire, il est connecté à un système de drainage, à une valve qui est située à l'extérieur du malade. Donc les indications, c'est surtout le patient qui présente une méningite. Donc l'infection, on ne peut pas faire un drainage interne car risque de décimation de l'infection et quantité du sang dans les ventricules parce que le sang, il est coagulé et donc si on met un système interne, ça va rapidement se boucher.

Donc ça, c'est le premier type. Puis on a les drainages ventriculaires internes et dans les drainages ventriculaires internes, on a deux choses. On a les systèmes avec chinte où on va mettre en place des valves, on va insérer des valves et le système sans chinte, c'est ce qu'on appelle la ventriculocystéernostomie, je pense qu'on en a parlé dans le cours.

Donc ça, c'est un procédé endoscopique et donc on va aller encore une fois par la couronne frontale du ventricule latéral, introduire l'endoscope, on va passer via le trou de Monroe au troisième ventricule et dans le plancher du ventricule, là, on va créer une stomie, un trou dans ce plancher pour faire communiquer le troisième ventricule avec les citernes de la base. Donc ça, c'est un procédé endoscopique. Puis on a, comme je vous ai dit, les ventriculopéritoneales, c'est-à-dire on va faire communiquer les ventricules avec le péritoine.

(31:49 - 33:03)

Oui, c'est possible parce que la paroi péritoneale peut elle aussi résorber le liquide céphalorachidien. Et là, en principe, on va ponctionner la corne occipitale du ventricule latéral. Donc, on va aller ponctionner la corne occipitale du ventricule latéral.

On va raccorder à une valve et on va tout mettre en sous-cutanée. Et le deuxième bout, on va l'insérer en l'intra-abdominal. Donc ça, c'est la dérivation ventriculopéritoneale.

On peut aussi faire une dérivation ventriculatriale, c'est-à-dire on va communiquer le ventricule avec les cavités cardiaques droites. Et là, le LCR va se résorber avec le sang veineux. Et puis, on a ce qu'on appelle aussi les dérivations lombopéritoneales.

Donc, on va faire une ponction, cette fois-ci un drainage du LCR au niveau de la partie lombaire et qui va se résorber au niveau abdominal. Je répète, les différentes dérivations qui existent. En général, il y a deux types, les dérivations externes et les dérivations internes.

(33:03 - 46:19)

Pour les dérivations externes, c'est ce qu'on appelle le drainage ventriculaire externe. Et pour les dérivations internes, on a les dérivations avec chinte et les dérivations sans chinte. Les dérivations sans chinte, ce sont des dérivations endoscopiques et c'est ce qu'on appelle VCS ou ventriculocystérostomie.

Et les dérivations avec chinte, on a les dérivations ventriculopéritoneales, les dérivations ventriculatriales et les dérivations lombopéritoneales. C'est lent, c'est beaucoup de technicité. Donc, vous allez revoir ça en pathologie quand vous allez voir le cours d'hydrocéphalie.

Mais voilà, j'ai essayé de vous faire un résumé des différentes procédés qu'on peut voir. C'est clair ça là ? Donc là, j'ai une question de Abdelbast. Je pense que j'ai zappé une question, je n'arrive pas à la revoir.

Bon, je réponds à Abdelbast. Est-ce qu'une personne peut vivre sanglante épiphyseuse après son ablation par exemple ? Donc, oui, mais ça sera très très lourd parce qu'il faudra une supplémentation de tous les axes. L'axe gonadotrope, l'axe stéréotrope, l'axe corticotrope, d'accord ? C'est possible.

Mais voilà, il faut savoir que dans la chirurgie épiphyseuse, en général, quand on a par exemple, c'est surtout les adénomes, quand on a un adénome épiphyseur, on enlève en général le tissu adénomateux et on laisse l'épiphyse normale. Mais des fois, voilà, on peut, dans certaines pathologies, donc ça vous allez le voir en pathologie, certaines pathologies comme la maladie de Cushing. Donc la maladie de Cushing, en général, on a des adénomes épiphyseurs, mais ce sont des tout petits, appelés micro-adénomes ou pico-adénomes, et qui sont même difficilement repérables par l'IRM et difficilement repérables en pair opératoire.

Et des fois, on a des syndromes de Cushing, mais quand on fait l'exploration radiologique, on ne voit rien. Et donc là, chez certains patients, on peut faire une épiphysectomie, c'est-à-dire qu'on enlève une partie de l'hypophyse, juste une partie, mais pas toute l'hypophyse. Mais voilà, c'est possible, oui, mais avec une supplémentation de tous les axes, ce qui est très très lourd, sur le plan médical.

Oui, le plexus corruïde existe dans tous les ventricules, et oui, la tige pituitaire relie l'hypophyse à l'hypothalamus. HIPAA, est-ce que la post-hypophyse était en contact direct avec les noyaux de l'hypothalamus? Tu veux dire comment ça, au direct, c'est-à-dire anatomiquement ou physiologiquement? Physiologiquement, oui, mais anatomiquement, non. Anatomiquement, la tige qui communique, qui fait communiquer l'hypothalamus avec la post-hypophyse.

La tige pituitaire relie la post-hypophyse à l'hypothalamus, et pas au V3, pour HIPAA. Je pense qu'il y avait une question pour laquelle je n'ai pas répondu. Donc il y a eu une question, je pense, voilà, je viens de la trouver, sur la fente de Bisha Ali.

Donc tu demandais que je réexplique la fente de Bisha. Donc la fente de Bisha, c'est un espace pymérien, c'est de la pymère qui entoure cet espace où se trouvent les vaisseaux corruïdiens, et

qui est limité en haut par le ventricule latéral, médialement par le trou de moraux, et en bas par le troisième ventricule. Madame, la tige pituitaire, ça j'ai répondu.

Où se trouve le plexus corruïde? Ça, cette question, je pense, on en a répondu plusieurs reprises. Le plexus corruïde se trouve au niveau des ventricules, donc c'est lui qui permet la sécrétion du liquide céphalorachidien, et on le trouve dans tous les ventricules. Donc les ventricules latéraux, au niveau du troisième ventricule se trouve au niveau, à hauteur du du trou de moraux, et au niveau du quatrième ventricule.

C'est clair, Fateme Zahra? Quel est le rôle de la neurohypophyse? Donc la neurohypophyse, son rôle majeur, c'est la sécrétion de l'ADH, l'hormone antidiurétique, rôle principal. Madame, s'il vous plaît. Bonjour, ça marche.

Madame, s'il vous plaît, la primaire et la durmaire ne sont pas vascularisées, le LCR est suffisant pour les nourrir? Oui, donc il y a le LCR, mais il y a aussi l'arachnoïde, il est riche en vaisseaux. D'autres questions? Où se trouvent les deux trous de moraux? Donc les trous de moraux, c'est ce qui fait communiquer le troisième ventricule avec les ventricules latéraux. Ils se trouvent au niveau de la paroi inférieure des ventricules latéraux.

Il y a un trou de moraux pour chaque ventricule latéral et donc chaque ventricule latéral communique avec le troisième ventricule par un trou de moraux. Il en existe deux. Oui, l'arachnoïde, il est non-vascularisé, mais il contient les vaisseaux.

Donc dans l'espace sous-arachnoïdien, on a les vaisseaux. Pour Ziyed, l'arachnoïde est non-vascularisé. L'arachnoïde et la pymère, ces deux membranes sont non-vascularisées.

(47:01 - 47:32)

Donc à Bdelbast, l'infundibulome du plancher du V3 se prolonge en bas par la tige 8-8R. C'est pas bien formulé, c'est pas l'infundibulome du plancher du troisième ventricule. Donc l'infundibulome, ça correspond à cette communication entre la tige 8-8R et l'hypophyse.

(47:32 - 53:16)

Donc c'est une partie de la tige 8-8R. D'accord ? Et il est en rapport avec le plancher du ventricule. Donc ce plancher du ventricule, il repose sur l'infundibulome.

Ok, à Bdelbast. Est-ce que c'est clair ? Ariane, madame, pouvez-vous expliquer l'espace périvasculaire de Virchow-Robin ? C'est un espace qui est périvasculaire, c'est-à-dire, je pense, c'est son nom qu'on parle. Donc Virchow-Robin, c'est juste le nom de celui qui l'a mis en évidence.

C'est un espace qui est virtuel, qui entoure les vaisseaux. Et surtout les vaisseaux dans l'espace sous-arachnoïdien. Zeyd, ça c'est une bonne question.

Est-ce que le sinus coronaire, c'est le sinus caverneux ? Non. Donc on a dit qu'on a les sinus

caverneux, deux de part et d'autre, de la loge hypophysaire. Et en fait, le sinus coronaire, c'est un sinus qui relie les deux sinus caverneux.

Donc vous imaginez, c'est ça la loge hypophysaire. Et latéralement, on a les deux sinus caverneux, un sinus caverneux de part et d'autre. Et le sinus caverneux, en fait, on le trouve en bas.

Donc il fait communiquer les deux sinus caverneux. C'est clair Zeyd ? D'autres questions ? Nouraila, tu voulais poser une question ? D'autres questions ? D'autres remarques ? Je vous pose moi une question. C'est une question qui ressort dans l'examen.

Je vais vous donner l'énoncé et vous me dites si c'est vrai ou faux. D'accord ? Donc l'antéhypophyse, il fait partie de la glande hypophysaire. Vrai ou faux ? L'antéhypophyse.

(53:17 - 54:56)

Vrai. Très bien. L'antéhypophyse est une glande d'origine nerveuse.

Très bien. Faux. Ok, c'est bien.

Donc je passe. L'antéhypophyse est une glande d'origine neuro-endocrine. Vrai.

Oui, très bien. Très bien. Donc je passe à la prochaine question.

L'antéhypophyse est en relation avec les noyaux du thalamus. Faux. L'antéhypophyse est en relation avec les noyaux de l'hypophyse.

C'est faux. Les noyaux du thalamus. Et dernière suggestion.

L'antéhypophyse, il fait partie de l'épiphysse. Très bien, c'est faux. Donc il y a eu une question ici, je viens de la voir, donc de Youssef Idrissi qui dit, est-ce qu'on peut dire que la vascularisation artérielle de l'hypophyse est nourricière et portale et fonctionnelle ? Oui, tu peux dire ça Youssef.

(54:56 - 56:01)

Donc la vascularisation artérielle de l'hypophyse est effectivement nourricière. La vascularisation portale est fonctionnelle parce que son rôle essentiel c'est l'acheminement des hormones. D'accord.

Je passe à une autre question. La vascularisation de l'hypophyse est assurée par deux artères. En fait trois.

Artère hypophysaire supérieure, inférieure et moyenne. Donc je passe à une autre question et vous me dites, l'abord chirurgical de la région est l'air. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé ça.

Donc vous répondez la même chose, vrai ou faux. L'abord chirurgical de la régence est l'air. Ah, la voie transcranienne est la seule voie chirurgicale.

(56:03 - 1:01:31)

La voie transcranienne est la seule voie chirurgicale. Vrai ou faux ? Très bien. Donc je passe à la voie transphénoïdale est la seule voie chirurgicale.

Très bien. Donc je passe. La voie transphénoïdale peut utiliser un endoscope.

La voie transphénoïdale utilise ou peut utiliser un endoscope. Très bien. C'est vrai.

Donc je passe. Je passe. Le diaphragme cellaire peut être ouvert accidentellement et donner une fuite de LCR.

Le diaphragme cellaire peut être ouvert accidentellement et donner une fuite de LCR. Très bien. Ça c'est vrai.

Donc dernière proposition, l'abord chirurgical de la régence est l'air permet d'accéder à l'hypophyse. L'abord chirurgical de la régence est l'air permet d'accéder à l'hypophyse. Très bien.

Voilà vous êtes capable de répondre aux questions. Ça sera simple. Ne vous inquiétez pas.

Donc je passe pour une question sur les méninges. Les méninges sont divisés en paquiméninges et leptoméninges. Les méninges sont divisés en paquiméninges et leptoméninges.

Vrai ou faux ? Très bien. Je passe. Deuxième proposition.

Quelle est la procédure à suivre s'il y a ouverture du diaphragme cellaire ? Ok Justine, je réponds à ta question. En cas d'ouverture du diaphragme cellaire, on essaie de refermer en mettant en place une plastie. Une plastie c'est un patch.

Cette plastie soit on va prélever de la graisse au niveau de l'abdomen, soit on va prélever de la fasciolata au niveau de la cuisse et on remet ça en place et on s'aide avec ce qu'on appelle une colle biologique. On met de la colle biologique et on va voir par la suite comment ça se passe. D'accord ? Tu peux me demander Husa pourquoi on met la graisse ? Donc la graisse on la met parce qu'en fait la graisse est hydrophobe.

Elle ne permet pas le passage des liquides. Notamment elle va obstruer et ne va pas permettre le passage du liquide céphalo-rachidien. Elle va stopper l'arénorée.

Donc ça c'est en théorie mais en pratique des fois ce n'est pas toujours facile. Donc en général nous on perd opératoire quand on a une ouverture du diaphragme cellaire. C'est ce qu'on fait.

On fait soit un prélèvement soit de la graisse soit de la fasciolata et on renforce ça avec de la

colle biologique. C'est bon Hussa ? J'ai pu répondre à tes questions ? Donc je continue. Donc on disait les méninges.

Donc on a répondu à la première proposition. Deuxième proposition concernant les méninges toujours. Les leptoméninges sont représentés par la durmère et l'arachnoïde.

Les leptoméninges sont représentés par la durmère et l'arachnoïde. Très bien. Donc je passe.

Je passe à une autre proposition. Les méninges se trouvent uniquement au niveau crânien. Les méninges se trouvent uniquement au niveau crânien.

Très bien c'est faux parce que les méninges se trouvent aussi, ils entourent la moelle au niveau du canal rachidien et ils entourent aussi les racines de la queue de cheval puisque ça crame. Les méninges, concernant toujours les méninges, une autre proposition. Une brèche de la durmère peut donner une fuite de liquide céphalo rachidien.

Une brèche de la durmère peut donner une fuite de liquide céphalo rachidien. Très bien Sarah, c'est vrai. Donc une brèche de la durmère peut donner une fuite de liquide céphalo rachidien, c'est vrai.

Ok. Ouissal, Ouissal, c'est vrai. D'accord.

(1:01:32 - 1:06:57)

C'est clair. Oui Ariane. Madame, le LCR ne se trouve pas dans l'espace sous-arachnoïdien? Oui, mais sur le plan pratique, ce n'est pas comme dans ce que vous voyez dans l'anatomie.

Donc la durmère est juste à côté, c'est des millimètres. En général, quand tu as une ouverture de la durmère, il y a aussi une ouverture de l'arachnoïde. D'accord? Donc c'est pourquoi une brèche de la durmère, oui.

Est-ce que si on brèche la durmère de façon très spécifique, de sorte que ça ne touche pas l'arachnoïde, est-ce qu'il y aura une fuite du LCR? Donc en théorie, oui. Si tu as juste une ouverture de la durmère toute seule, mais en pratique chirurgicale, comme je vous ai dit, ce sont des espaces qui sont très étroits. En général, dès qu'on ouvre la durmère, l'arachnoïde est juste à côté et ça peut donner une fuite de liquide céphalorachidien.

D'accord? Une brèche, quand on dit brèche durmérienne, donc une brèche durmérienne peut s'étendre jusqu'à l'arachnoïde. Vous n'allez jamais entendre une brèche arachnoïdienne. On dit toujours une brèche durmérienne et ça sous-entend qu'il y a aussi une lésion de l'arachnoïde sous-jacente.

D'accord? Le terme brèche durmère, ça signe qu'il y a aussi une atteinte de l'arachnoïde. Ça va? Et donc ça, c'est vrai. Quand vous entendez le mot brèche, ça veut dire que l'arachnoïde est intacte.

Est-ce que la durmère est en contact avec le LCR? Via l'arachnoïde. Pas directement, mais via l'arachnoïde. Mais comme je vous ai dit, en pratique chirurgicale, anatomiquement, ce n'est pas à coller, mais ils sont l'un à côté de l'autre.

De telle façon qu'en ouvrant la durmère, le plus souvent on ouvre avec l'arachnoïde. Parce que l'arachnoïde est très très fragile. La durmère est solide, mais l'arachnoïde est très fragile.

D'accord? C'est clair pour cette question? Quand vous trouvez le mot brèche, ça veut dire que l'arachnoïde est atteinte. Et brèche, ça veut dire fuite de LCR. Cette proposition, une brèche de la durmère peut donner une fuite de liquide céphalo-rachidien? Oui.

C'est clair? Oui, madame. Dernière proposition, l'espace extra-dural contient du LCR. L'espace extra-dural contient du LCR.

Oui, c'est faux. Très bien. Très très bien.

Je passe à une autre question ou vous voulez me poser une autre question parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps? Il reste à peu près cinq minutes. Donc une autre question. La paroi latérale du troisième ventricule.

La paroi latérale du troisième ventricule correspond à la glande pinéale. Très bien, c'est faux. C'est faux.

Je passe à une autre proposition. Il correspond au thalamus. La paroi latérale du troisième ventricule correspond au thalamus.

Vous avez demandé mon mail. Il y a quelqu'un qui a demandé mon mail. Je vais vous l'écrire.

Voilà, c'est envoyé. Très bien, donc c'est vrai. La deuxième proposition, oui, la paroi latérale du troisième ventricule correspond au thalamus.

(1:06:57 - 1:09:35)

Troisième proposition, la paroi latérale du troisième ventricule correspond au chiasma optique. Vrai ou faux? C'est faux. La paroi latérale du troisième ventricule correspond au sinus fénoidal.

Vrai ou faux? Oui, c'est faux. La paroi latérale du troisième ventricule correspond au corcaleux. Très bien, c'est faux.

Donc la seule proposition, c'est la deuxième proposition, donc c'est le thalamus. Madame? Oui, Ariane. S'il vous plaît, la région scélère, ça contient juste la loge hypophysaire? Oui, dans la région scélère, on trouve juste la loge hypophysaire.

Donc c'est la loge hypophysaire et voilà, il y a des rapports que vous avez vus dans le cours. Mais c'est la loge hypophysaire. Je passe à une question sur ce sujet-là.

La selle thursique est située au niveau de l'étage postérieur de la base du crâne. Vrai ou faux?

Donc c'est non. Très bien.

La selle thursique est impaire. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Très bien.

(1:09:38 - 1:12:08)

Donc la selle thursique contient la glande hypophyse. Oui, c'est vrai. Donc je passe.

La selle thursique contient le quatrième ventricule. Donc c'est faux. Très bien.

Arja, tu as dit c'est vrai, c'est faux. D'accord? La selle thursique ne contient pas le quatrième ventricule. La selle thursique est formée par l'os frontal.

La selle thursique est formée par l'os frontal. Donc c'est faux. D'accord? Donc les propositions sont juste.

La selle thursique est impaire et la selle thursique contient la glande hypophysaire. Ok? Arja, la dernière proposition est fausse. Donc la selle thursique est formée par l'os fénoidal et pas par l'os frontal.

Oui, Ariane? Est-ce qu'on peut dire que la loge hypophysaire se trouve dans la selle thursique? Oui, on peut dire la loge hypophysaire se trouve dans la selle thursique. C'est bon? Il reste une minute. Si vous avez une question, mais sinon je vous ai envoyé mon mail, comme ça si vous avez plus de remarques ou d'incompréhension, vous pouvez m'envoyer directement via mon mail.

Ça va? Merci beaucoup, ma belle. Merci à vous, c'était en tout cas intéressant. J'espère que cela a été pour vous également.

Je vous souhaite bon courage et voilà. Très bonne journée.